

Dalla Paura alle Difese

Salute Mentale · Sessione 04 · 11.03.2026

Questa lezione è una delle più dense del corso — e anche una delle più utili per il tuo futuro lavoro. Partiamo da un mito greco, atterriamo nella neurobiologia delle emozioni, e arriviamo a capire perché i tuoi utenti a volte si comportano in modo che sembra incomprensibile. Buckle up.

Il mito di Perseo e la Gorgone: la paura in forma di storia

Il prof apre con un mito — e non lo fa per caso. Le storie che durano millenni raccontano verità psicologiche universali, quelle che gli antichi non avevano un altro modo per dire.

Medusa è la Gorgone mortale, la "paura alla sua ennesima potenza": chiunque la guardi direttamente negli occhi viene pietrificato. Lei non aggredisce nessuno — vive nei suoi luoghi lontani e inaccessibili. Il problema è se vai da lei e la guardi direttamente.

Perseo viene incaricato di tagliarle la testa. Prima di affrontarla, scende nei luoghi inferi e si attrezza: riceve un sacco per contenere la testa recisa, calzari alati per muoversi velocemente, l'elmo di Ade che rende invisibili. Poi ottiene due doni fondamentali da due divinità:

- Da **Atena** (dea della sapienza e della guerra): uno **scudo lucido** come uno specchio. Il prof sottolinea che il verbo "riflettere" vale sia per gli specchi che per il pensiero — non è un caso.
- Da **Erme**s: un falchetto per tagliare la testa.

Arrivato vicino alla dimora di Medusa, Perseo capisce dove si trova vedendo i corpi pietrificati di chi aveva tentato prima di lui. Aspetta che lei si addormenti, poi — senza guardarla direttamente — usa lo scudo come specchio per vederla in modo

indiretto. La decapita mentre dorme, chiude la testa nel sacco e riparte. Da quel momento in poi, quella testa diventerà il suo "superpotere" per affrontare altre minacce.

Cosa ci dice questo mito sulla paura

Il mito trasmette almeno tre messaggi fondamentali:

1. **Le paure, anche le più grandi, si possono affrontare** — a condizione di attrezzarsi bene. Non basta il coraggio a testa bassa: chi si è avvicinato a Medusa senza preparazione è rimasto di sasso. Letteralmente.
2. **Occorre un medium** — non si guarda la paura frontalmente, ma di riflesso. Lo scudo di Atena rappresenta la capacità di *riflettere*, di pensare, di mediare l'incontro diretto con ciò che ci spaventa. Visto di riflesso, il pericolo è "meno deflagrante, meno pietrificante, più trattabile sia emotivamente che cognitivamente".
3. **Una volta affrontata, la paura diventa risorsa** — la testa di Medusa, per quanto macabra, diventa un capitale che Perseo usa per aiutare altri. Aver elaborato le proprie paure non ti rende automaticamente esperto delle paure altrui (attenzione: questo sarebbe **empatia egocentrica**, una forma di arroganza relazionale), ma ti rende più capace di stare vicino a qualcuno senza andare in tilt.

Il prof sottolinea con forza: il punto non è "ci sono passato anch'io, so come la senti". Il punto è "ho incontrato le mie paure, le conosco, e quindi quando incontro le tue non vengo travolto".

Il lato oscuro: chi è davvero Medusa?

Qui il prof ribalta il punto di vista in modo potente, citando Ovidio (*Metamorfosi*, libro IV).

Medusa **non era nata mostro**. Era la più bella delle tre sorelle Gorgoni, la più desiderata. Un giorno Poseidone (il dio del mare) la violenta nel tempio di Atena. La scena è così orribile che la dea si copre il volto con il mantello. Poi — e qui la storia è

disturbante — Atena trasforma Medusa nel mostro che conosciamo: capelli di serpenti, sguardo pietrificante. Non punisce l'aggressore. Trasforma la vittima.

Il "mostro" è il risultato di una mostruosità subita. Medusa non aggredisce nessuno di propria iniziativa: se ne sta a casa sua. È pericolosa solo se ci vai tu.

Il prof collega questo direttamente al lavoro sociale:

"Noi vediamo il mostro. Ma spesso non vediamo ciò che li ha trasformati in mostro."

I vostri utenti "difficili", scontroso, inavvicinabili — a volte sono Meduse. Persone che hanno subito qualcosa di orribile e che si sono costruite una corazza per sopravvivere. La "mostruosità" che vedete è spesso una **protezione**, non un'identità.

E attenzione: guardare negli occhi la storia di Medusa — cioè ascoltare davvero cosa ha vissuto un utente — può pietrificare anche voi. Ci sono cose che fanno spostare la testa dall'altra parte. È una reazione umana. Ma "fare come se non ci fosse" quel qualcosa abbandona la persona alla conferma che la sua storia è inguardabile, e che lei stessa lo è.

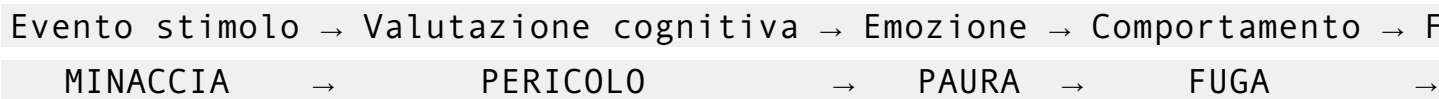
Fin qui ci siamo? Bene — ora entriamo nella parte più tecnica, ma non meno importante.

Anatomia della paura: come funziona un'emozione

Paura: definizione e funzione evolutiva

La **paura** è prima di tutto un'**emozione**. Darwin (1872) la collegava all'etimologia di qualcosa di *pericoloso e improvviso*, mentre il "terrore" evocherebbe il tremito degli organi. La paura ci predispone a individuare il pericolo tempestivamente e a reagire.

Funzionalmente, la paura segue una **filiera** precisa (elaborazione di Pezzoli da Plutchik, 2017):



Attenzione: la **valutazione cognitiva** è *proto-cognitiva*, cioè veloce e automatica — non è un ragionamento cosciente. Può prendere cantonate, ma conta la velocità. Pensa a come in un bosco reagisci al bastone che sembra un serpente: la reazione arriva prima del pensiero.

Le emozioni in generale hanno: - Un **oggetto** (la paura ha una minaccia specifica) - Una **durata breve** (funzionale all'azione immediata) - Una **risposta comportamentale** tipica - Uno **scopo** (per la paura: salvarsi, conservarsi)

Emozioni vs. sentimenti vs. umori

Il prof fa una distinzione che tornerà più volte nel corso:

	Emozione	Sentimento	Umore
Oggetto	Sì, specifico	Sì/No (può essere diffuso)	No
Intenzionalità	No (non si sceglie)	Sì (posso scegliere di amare)	No
Durata	Breve	Lunga	Prolungata/ diffusa
Esempio	Paura di un cane	Amore per una persona	Tristezza di fondo

La differenza fondamentale: le emozioni *non si scelgono*, i sentimenti sì.

Le tre risposte etologiche alla paura

A livello biologico, di fronte a una minaccia percepita, ci sono tre risposte possibili:

1. **Fuga** — la risposta comportamentale tipica
2. **Attacco** — quando la fuga è impossibile (il gatto in un angolo che non può scappare)

3. **Mimetismo/immobilità** — sparire dalla vista del predatore

Il prof collega immediatamente queste tre al lavoro sociale. Esempio concreto:

Un utente tossicodipendente che ti attacca durante un colloquio non è necessariamente aggressivo per natura — potrebbe essere un gatto in un angolo. Se non gli dai vie di fuga (fisiche, psicologiche, relazionali), l'attacco è la sua unica opzione.

Vie di fuga concrete che il prof suggerisce: porta aperta durante il colloquio, possibilità di portare una persona di fiducia, pause esplicite, spiegare che può uscire se si sente sopraffatto. Non dare per scontato che l'utente capisca da solo che può farlo.

Il mimetismo si vede in quegli utenti che sembrano "troppo tranquilli" — non ti danno problemi, non li vedi nei problemi, e poi scopri che hanno fatto pasticci altrove.

Quando la paura si inceppa: intensità e durata

La paura smette di essere funzionale in due situazioni:

1. Intensità eccessiva → freezing (blocco)

Sopra una certa soglia di **arousal** (attivazione fisiologica), invece di mettere in atto la fuga o l'attacco, ci si blocca. Freud lo aveva già notato: *"Se l'angoscia raggiunge un'intensità eccessiva, si dimostra assai inappropriata, paralizza ogni azione, compresa quella della fuga."* (Freud, *Introduzione alla psicoanalisi*, 1915)

Il prof racconta di una paziente molestata dal parrucchiere che si è bloccata completamente invece di reagire — e questo blocco è stato interpretato dall'aggressore come consenso. Il freezing non è una scelta: è una risposta automatica all'iper-attivazione.

Implicazione pratica: quando un utente è troppo attivato emotivamente, il tuo primo compito è abbassare quell'attivazione. Solo dopo si può lavorare. Voi siete lo "scudo di Atena" — mediate l'incontro con la paura.

2. Durata eccessiva → esaurimento delle risorse

Un pericolo percepito che dura troppo a lungo consuma le risorse del soggetto e può portare a cercare soluzioni temporanee (alcol, farmaci, sostanze) per sospendere l'esposizione. Come nota Oliverio Ferraris (1998), il "duplice effetto" della paura è questo: "salvarci dal pericolo, stimolarci, oppure bloccare le nostre capacità o impegnarci in attività senza senso."

Il contesto conta: la mappa dell'ambiente

La paura non dipende solo dalla minaccia, ma anche dall'**ambiente** in cui la si vive. Pezzoli presenta uno schema a quattro quadranti (elaborazione originale):

	Ambiente familiare/ conosciuto	Ambiente non familiare
Minaccia presente	Area di pericolo (ma con risorse)	Area di massimo allarme
Minaccia assente	Area di comfort	Area di attenzione (anticipazione)

Esempio del prof: un migrante che si sente male in un posto dove non conosce la lingua, non sa a chi chiedere aiuto, e chi "dovrebbe" aiutarlo in passato lo ha maltrattato — è nell'area di massimo allarme. La stessa malattia in contesto familiare è gestibile in modo completamente diverso.

"Non dare mai per scontato la dimensione del dove sta e dove vive il tuo paziente."

Quando il soggetto si trova in un nuovo contesto (un ricovero, un nuovo servizio, persino la prima settimana di scuola), mette in atto processi di familiarizzazione — con gli ambienti e con le persone. A volte in modo maldestro: idealizzazione, doni, complimenti esagerati ("tu sei il curante più sensibile che abbia mai incontrato"). Sono tentativi di rendersi sicuro il territorio. Riconoscerli aiuta a non cascarci e a rispondere in modo appropriato.

Pauro vs. ansia: non sono la stessa cosa

Questo è un punto chiave che il prof vuole molto chiaro. **Pauro e ansia non sono sinonimi** — non a livello psicologico, e nemmeno a livello neurologico.

- La **pauro** ha un oggetto specifico, una minaccia reale e presente. Durata breve. Coinvolge principalmente l'**amigdala**.
- L'**ansia** non ha oggetto definito, è proiettata nel futuro, dura nel tempo. Coinvolge il **Nucleo della stria terminale (BNST)** — *Bed Nucleus of the Stria Terminalis* — una struttura limbica diversa (Grillon, 2008).

L'ansia è, per Plutchik (a cui si rifà il prof), una combinazione di due emozioni base: **pauro + anticipazione**. È la pauro privata del suo oggetto e del suo tempo presente.

Come metafora: la pauro è un imbuto che si restringe verso un obiettivo specifico (quella minaccia lì). L'ansia è un imbuto al contrario — si allarga verso l'indeterminato, verso il "cosa potrebbe succedere?".

Freud distingueva tra *angoscia reale* (la nostra pauro: risposta a pericolo esterno identificato) e *angoscia nevrotica* (la nostra ansia: "liberamente fluttuante, pronta ad agganciarsi ad ogni contenuto rappresentativo adatto").

La classificazione clinica di ansia normale vs. patologica segue questi criteri (adattamento Pezzoli da Biondi, 1996):

Criterio	Ansia normale	Ansia patologica
Intensità	Lieve-moderata	Moderata-intensa
Durata	Limitata nel tempo	Lunga o con postumi
Frequenza	Episodi poco frequenti	Episodi frequenti o continui
Reazione	Appropriata alla situazione	Inappropriata/sproporzionata
Sofferenza	Limitata e temporanea	Evidente, frequente
Conseguenze		

Criterio	Ansia normale	Ansia patologica
	Compromette poco la funzionalità	Compromissione della libertà/funzionalità

Il prof cita anche la **sorpresa**: emozione anticipatoria che si attiva quando qualcosa di inatteso appare nel campo esperienziale. Risposta comportamentale: fermarsi ("stop") per capire se si tratta di una minaccia. Solo quando la risposta alla domanda "che cos'è?" diventa "è una minaccia" — parte la paura.

Le tre fonti di angoscia: Freud e "Il disagio della civiltà"

Freud, in uno degli ultimi scritti importanti (*Il disagio della civiltà*, 1930), identifica tre fonti fondamentali di minaccia per l'essere umano:

"La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo che, destinato a deperire e a disfarsi, non può eludere quei segnali d'allarme che sono il dolore e l'angoscia, dal mondo esterno che contro di noi può infierire con strapotenti spietate forze distruttive, e infine dalle nostre relazioni con altri uomini." (Freud, 2001, pag. 212)

1. **Il corpo** — ci ammaliamo, deperiamo, moriamo. Il corpo può persino non piacerci — e anche questo diventa una fonte di angoscia.
2. **La natura** — terremoti, malattie, catastrofi. Da sempre fonte di minaccia per l'uomo.
3. **Le relazioni con gli altri** — per Freud la più importante. Le altre persone possono essere la nostra rovina, ma anche la nostra salvezza: il lockdown lo ha dimostrato in entrambe le direzioni.

Il prof cita la metafora dei **porcospini di Schopenhauer** (*Parerga e paralipomena*): si avvicinano per scaldarsi, ma le spine si feriscono e devono allontanarsi. Trovano alla fine una distanza moderata — né troppo fredda né troppo pungente. Non esiste una "distanza giusta" universale in centimetri: dipende dalla specificità di ogni relazione, e cambia nel tempo.

I meccanismi di difesa: cosa sono e perché esistono

Eccoci al cuore della lezione. Tutto il discorso sulla paura e l'angoscia serviva come fondamenta per arrivare qui.

Definizione fondamentale

I **meccanismi di difesa** (MDD) sono: - **Automatici** (si attivano senza decisione cosciente) - **Inconsci** (non se ne è consapevoli) - **Attivati dall'Io** sotto la pressione dell'angoscia - **Scopo principale**: difendere il soggetto dall'angoscia — **non** dalla minaccia in sé

Anna Freud li definisce nel suo testo fondamentale *L'Io e i meccanismi di difesa* (1936). Il padre Sigmund aveva introdotto il concetto nel 1894 per descrivere "la lotta dell'Io contro idee o affetti dolorosi e insopportabili".

Il punto cruciale, che il prof ripete più volte: i MDD difendono dall'**angoscia**, non dal **pericolo** che la genera. Con l'esempio del neo che cambia aspetto sulla pelle: il diniego ti toglie l'angoscia ma non ti protegge dal melanoma che intanto avanza.

I tre tipi di angoscia (Anna Freud)

L'angoscia che i MDD devono fronteggiare può provenire da tre istanze: - **Angoscia istintuale** (dall'Es che preme per soddisfazione immediata) - **Angoscia del reale** (dalla realtà esterna minacciosa) - **Angoscia morale** (dal Super-Io che impone divieti e sanzioni)

Come valutare i meccanismi di difesa

Tre criteri fondamentali (Anna Freud, poi ripresi da Perrotta, 2020):

1. **Age adequateness** — è adeguato all'età? Un bambino che nega il pericolo è normale; un adulto che lo fa sistematicamente no.
2. **Intensity** — quanto distorce la realtà?

3. **Balance** — il soggetto usa una varietà di difese o è bloccato sempre sulle stesse?

Il **potenziale disadattivo** cresce quando (Perrotta, 2020): - La difesa è usata in modo esclusivo, rigido, ripetitivo - L'intensità (distorsione della realtà) è elevata - Non è adeguata all'età - Non è adeguata al contesto

I meccanismi di difesa primitivi

Si sviluppano nella prima infanzia. Sono drastici, semplici, molto efficaci nel togliere l'angoscia — ma distorcono molto la realtà e impediscono l'incontro con il problema che la genera.

Regola pratica del prof: quando osservate in un adulto meccanismi di difesa molto primitivi, vuol dire che è **molto angosciato**. Il tipo di difesa vi dà il grado di angoscia. Non è un adulto "difficile" per carattere — è profondamente spaventato.

Ritiro primitivo

Il più antico. Di fronte a una sovrastimolazione che non si può gestire, il soggetto si "ritira": il bambino si addormenta alla festa rumorosa.

Nell'adulto: uso di sostanze, videogiochi in modo ossessivo, rifugio in mondi fantastici, dormire eccessivamente. Non è una strategia — è automatico. Il prof racconta dell'ufficiale di polizia che si è addormentato durante una conferenza dove mostravano scene del crimine particolarmente pesanti: il suo sistema psichico ha messo in atto il ritiro primitivo senza preavviso.

Nell'adulto, la dominanza di questo meccanismo può segnalare una personalità **schizoide**.

Diniego

Non si *vede* ciò che genera angoscia. Non è la chiusura verso il mondo del ritiro primitivo: è la negazione selettiva della realtà a livello percettivo.

Esempio del prof: genitori che non si accorgono della dipendenza del figlio — non perché siano stupidi o disattenti, ma perché vedere quella cosa genererebbe un'angoscia insostenibile. Il loro sistema psichico ha "spento" quella percezione.

Il diniego è ancora più radicale della rimozione: nella rimozione c'è un primo contatto con la realtà che poi viene "dimenticata"; nel diniego la realtà angosciante non viene proprio percepita.

Pollyanna (dal romanzo di E.H. Porter, 1913) è l'esempio letterario: l'ottimismo sfrenato e la visione costantemente positiva di tutto possono essere una forma di diniego. "Vedere il bicchiere mezzo pieno" è sano; non riuscire mai a vedere la parte vuota è una difesa che impedisce di affrontare i problemi reali.

Proiezione

Si attribuisce a qualcun altro un proprio stato interno (pensiero, emozione, impulso) che risulterebbe troppo angosciante se riconosciuto come proprio.

"Ho dell'aggressività verso qualcuno che amo. Questo crea un conflitto insostenibile. Allora non è che ho l'aggressività io — è lui che ce l'ha con me."

Introiezione

Il contrario della proiezione: si fanno proprie caratteristiche, modi di fare, valori dell'altro. Nei bambini è normale e funzionale (introiettare le caratteristiche dei genitori è rassicurante). La forma patologica più estrema è l'**identificazione con l'aggressore**: di fronte all'impotenza di essere vittima, l'unica via d'uscita percepita è diventare come chi ti fa del male. Il bambino che ha paura dei fantasmi nel buio e poi si mette il mantello da fantasma e corre per casa facendo paura agli altri.

Identificazione proiettiva

Meccanismo complesso, molto presente nell'adolescenza e in alcuni disturbi di personalità. Non basta proiettare un contenuto sull'altro: si agisce nella relazione in

modo da far sì che l'altro *provi davvero* ciò che gli è stato proiettato. Il contatto diretto è fondamentale.

Il prof fa un esempio di lavoro sociale:

Un utente arriva dall'assistente sociale frustrato e convinto che nessuno riesca ad aiutarlo. L'assistente, carico di buona volontà, costruisce un progetto dopo l'altro — e l'utente fa fallire tutti. Alla fine, l'assistente sociale prova esattamente le stesse emozioni dell'utente all'inizio: frustrazione, senso di inadeguatezza, rabbia. Ha vissuto dall'interno il mondo interno dell'utente.

Un collega ha chiesto se assomiglia all'**effetto Golem** (la profezia che si autoavvera): il prof dice che c'è una similitudine, ma nell'identificazione proiettiva il meccanismo è inconscio e relazionale — l'utente attivamente (ma senza saperlo) ti provoca quei sentimenti.

Scissione

Il mondo viene diviso in buoni e cattivi, tutto bianco o tutto nero. È normale nei bambini piccoli (e nelle fiabe: la fata buona e la strega cattiva). Il problema è quando persiste nell'adulto.

Mélanie Klein ha studiato il passaggio dalla **posizione schizoide** (scissione netta) alla **posizione depressiva** (la capacità di tenere insieme aspetti positivi e negativi della stessa persona). Il termine "depressiva" non c'entra con la depressione clinica — indica la capacità di tollerare la complessità e l'ambivalenza.

Idealizzazione e svalutazione

Meccanismi speculari. L'idealizzazione amplifica le qualità positive di qualcuno per sentirsi al sicuro. È comprensibile e funzionale in certi momenti (chi è molto angosciato ha bisogno di pensare che chi lo segue sia molto capace) — ma va riconosciuta.

Il prof avverte: se un paziente/utente ti idealizza molto, non è (solo) perché sei bravo. È perché è molto angosciato. Quando quella sicurezza viene meno, l'idealizzazione si capovolge in svalutazione immediata.

Controllo onnipotente

Si basa sull'**egocentrismo primitivo** (tutto dipende da me) e sul **narcisismo primario** (io sono il mondo). Nell'adulto si manifesta come necessità di controllare gli altri, esercitare potere. Il prof sottolinea l'ironia: chi ha bisogno di controllare tutto è spesso molto fragile dentro. Alcune declinazioni professionali: figure dirigenziali autoritarie, ambienti di spionaggio, politica.

I meccanismi di difesa secondari (o maturi)

Compaiono dopo la prima infanzia. Sono più complessi, distorcono meno la realtà, mantengono un maggiore contatto con la dimensione conflittuale che genera angoscia.

Il prof li organizza in tre blocchi funzionali (raggruppamento didattico, non un criterio standard da manuale):

Blocco 1 — Dimenticare: rimozione e dissociazione

Rimozione: sposta nell'inconscio pensieri, idee, affetti che generano angoscia. Si parte da un primo contatto con la realtà, poi si "dimentica". Esempio: provare agitazione inspiegabile quando ci si avvicina a qualcuno verso cui si è rimossa aggressività. La dissociazione del pensiero dall'emozione può manifestarsi anche in modo leggero: aprire la porta di casa con le chiavi dell'ufficio è una piccola rimozione.

Dissociazione: crea una discontinuità nell'esperienza mnestica e sensoriale. Usata soprattutto nei traumi. Guardare fuori dal finestrino del treno nel vuoto è una lieve dissociazione; non sentire il proprio corpo durante un abuso è una dissociazione grave.

Blocco 2 — Spostare: formazione reattiva, regressione, capovolgimento, spostamento

Formazione reattiva: si trasforma un affetto negativo nel suo opposto esagerato. Il bambino che odia il fratellino appena nato ma si comporta come il suo migliore papà, prendendosi cura di lui un po' troppo intensamente (i "giri della morte" descritti dal prof). Tutte le volte che qualcuno ti "ama troppo" o ti tratta con un eccesso di gentilezza innaturale.

Spostamento: si sposta l'obiettivo di un sentimento su qualcosa di meno "pericoloso". Il datore di lavoro urla agli operai (che di solito se ne vanno in vacanza alle Seychelles) invece di scaricare la frustrazione direttamente su chi la provoca.

Capovolgimento (passivo → attivo): "Io vorrei ricevere attenzioni → do attenzioni agli altri." Gestire attivamente ciò che si vorrebbe ricevere passivamente.

Blocco 3 — Separare: isolamento, razionalizzazione, intellettualizzazione, moralizzazione, compartimentalizzazione

Il meccanismo di base di questo gruppo è l'**isolamento degli affetti**: si separa la componente emotiva da quella cognitiva, mettendo da parte la parte che fa male.

Intellettualizzazione: si parla di emozioni in modo distaccato, senza entrarci in contatto. Come il vulcaniano di Star Trek. Il soggetto racconta cose emotivamente cariche con una "totale freddezza emotiva e apatia sconcertanti" — descrizione che il manuale usa proprio per i sopravvissuti a traumi.

Razionalizzazione: si costruisce una spiegazione razionale per evitare il contatto emotivo. La volpe che non raggiunge l'uva e dice "tanto non era matura". Gli "spiegoni" che ci diamo dopo aver fatto qualcosa di cui ci vergogniamo.

Moralizzazione: si dà una cornice etico-morale all'esperienza. "Queste esperienze ci vogliono, ci fanno crescere" — detto con troppa sicurezza prima di aver davvero elaborato.

Compartimentalizzazione: due dimensioni cognitive incompatibili coesistono nello stesso soggetto senza mai entrare in contatto. Il moralista di giorno che di

notte... Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Non è ipocrisia consapevole: le due cose "abitano stanze diverse" e metterle in contatto sarebbe troppo angosciante.

La scala di maturità: un quadro d'insieme

I MDD si organizzano lungo due assi:

- **Asse orizzontale:** comparsa nel tempo (primitivi → maturi)
- **Asse verticale:** grado di distorsione della realtà (alta → bassa) / complessità (bassa → alta)

Più ci si sposta verso il basso (primitivi), più la distorsione della realtà è alta e la difesa è semplice. Più ci si sposta verso l'alto (maturi), meno si distorce la realtà ma il meccanismo è più complesso.

La classificazione in livelli (adattamento Pezzoli da Perrotta, 2020):

Livello	Tipo	Esempi
7°	Difese mature	Altruismo, affiliazione, umorismo, sublimazione
6°	Difese ossessive	Annullamento retroattivo, intellettualizzazione, isolamento degli affetti
5°	Difese nevrotiche	Rimozione, formazione reattiva, spostamento
4°	Difese narcisistiche	Idealizzazione, svalutazione, onnipotenza
3°	Difese di disconoscimento	Diniego, proiezione, denegazione
2°	Difese borderline	Scissione, identificazione proiettiva
1°	Difese di azione istintiva	Acting-out, scissione
0	Rottura con la realtà	Negazione psicotica, distorsione psicotica, proiezione delirante

Il prof aggiunge la dimensione dell'**umorismo** come esempio di difesa molto matura: un paziente che fa battute sulla propria malattia non è solo simpatico — è in contatto con la sua situazione (a differenza del diniego) e la elabora trasformandola in qualcosa di condivisibile. È un meccanismo complesso che mantiene il contatto con il problema pur attenuandone l'angoscia.

"Quando un paziente usa troppa ironia, non è un paziente simpatico — è comunque un paziente angosciato. Ma è in contatto con quella roba lì." (Il prof)

Angosce diverse per patologie diverse

Le tre grandi aree psicopatologiche hanno angosce e difese dominanti diverse — un tema che sarà sviluppato nelle lezioni successive:

- **Nevrosi** → angoscia di castrazione (di limite, di prestazione)
- **Psicosi** → angoscia di frammentazione (perdere l'unità della propria identità)
- **Borderline/Stato limite** → angoscia di abbandono

Concetti chiave

Termine	Significato
Paura	Emozione con oggetto specifico (minaccia presente), durata breve, attiva l'amigdala
Ansia	Stato emotivo diffuso senza oggetto specifico, proiettato nel futuro, attiva il BNST
Angoscia	Nel linguaggio freudiano: sia la paura reale che l'ansia nevrotica. In lezione: il disagio profondo che attiva le difese
Freezing	Blocco da iper-attivazione: sopra una certa soglia di arousal ci si paralizza invece di reagire
Meccanismo di difesa	

Termine	Significato
	Risposta automatica, inconscia, attivata dall'Io per ridurre l'angoscia (non il pericolo)
Ritiro primitivo	MDD primitivo: disattivazione del contatto con la realtà stimolante
Diniego	MDD primitivo: non si vede (perceettivamente) ciò che genera angoscia
Proiezione	Si attribuisce agli altri propri stati interni insostenibili
Introiezione	Si fanno proprie caratteristiche dell'altro
Identificazione proiettiva	Si agisce nella relazione in modo da far sì che l'altro provi ciò che gli è stato proiettato
Scissione	Il mondo viene diviso in tutto buono o tutto cattivo, senza sfumature
Idealizzazione/ Svalutazione	Meccanismi speculari: amplificazione delle qualità positive o negative per gestire l'angoscia
Rimozione	MDD secondario: sposta nell'inconscio pensieri/affetti angoscianti dopo un contatto iniziale
Dissociazione	Discontinuità nell'esperienza sensoriale/ mnestica, legata ai traumi
Compartimentalizzazione	Due sistemi cognitivi incompatibili coesistono senza mai entrare in contatto
Age adequateness	Adeguatezza all'età: un MDD arcaico in un adulto segnala alta angoscia
BNST	Bed Nucleus of the Stria Terminalis: struttura limbica coinvolta nell'ansia (diversa dall'amigdala della paura)

Termine	Significato
Empatia egocentrica	Forma scorretta di empatia: "ci sono passato anch'io, so come ti senti" — da evitare

Collegamenti

- **Lezione 01:** introduzione alle emozioni come atto valutativo della realtà; la valutazione protocognitiva già citata.
- **Lezioni successive:** le tre grandi aree psicopatologiche (nevrosi, psicosi, borderline) — i MDD saranno fondamentali per comprenderle.
- **Modulo sulla violenza nelle relazioni intime:** l'ambiente familiare come paradossale fonte di minaccia.
- **Modulo sull'alessitimia:** le emozioni e la difficoltà di riconoscerle e nominarle.
- **Tema aperto — la distanza giusta:** la metafora dei porcospini di Schopenhauer tornerà nel corso.